

Status main et poignet

Cas clinique : Plaie (patient avec nerf ulnaire lésé et section du tendon du m. fléchisseur du 4^{ème} doigt)

1. Inspection (décrire) :

- a) Rougeur (trajet lymphangitique)
- b) Hématome (voir le dos de la main !)
- c) Plaie (bords nettes, taille, perte de substance, profondeur, ...)

2. Palpation :

- a) Vascularisation : gradient thermique, temps de recoloration paume/doigts, **test d'Allen**
- b) Zones douloureuses (infection ?)

3. Sensitif : yeux fermé

- a) Au touché (10 demi-pulpes, 2 paumes/2 dos, 3 avant-bras), regarder en amont de la plaie pour exclure un problème avant, attention annulaire : un côté ulnaire et un côté médian
- b) Si anormal = toucher/piquer (hypoesthésie/dysesthésie/hypo-dysesthésie/allodynie)
- c) Si anormal = discrimination entre deux points (si >5mm et détecte qu'un point, anesthésie)

4. Motricité distale (tendons + muscles) :

- a) Fléchisseur profond des doigts (avec pouce)
- b) Fléchisseur superficiel des doigts (immobiliser les autres doigts, profond bloquer)
- c) Abduction du **pouce** (demander au patient d'amener son pouce vers son nez + R, dos de la main sur la table) → **n. médian**
- d) Abduction **index** (main posée sur le côté, demander de lever l'index contre R) et **auriculaire** (demander d'écarter l'auriculaire contre R) → **test n. ulnaire (test de froment)**
- e) Extension des doigts → **n. radial**

DD : nerf ulnaire lésé et section du tendon du m. fléchisseur du 4^{ème} doigt

Prise en charge : intervention chirurgicale

Si plaie poignet bas :

Toute lésion sensitive (toucher ou moteur) découlant de cette plaie sera distale à la plaie.

Toute perte motrice des muscles de l'avant-bras (ex : fléchisseur superficiel des doigts) sera due à une rupture d'un tendon (OU à une lésion de l'innervation des muscles et qui n'a rien à voir avec la plaie car muscles sont proximaux à la plaie).

En revanche, une lésion du nerf des muscles intrinsèques de la main peut être observée car ces muscles (tenons et muscles) se situent distalement à la plaie.

Au niveau de la sensibilité, on ne parle plus de dermatomes (qui font référence à des racines de nerfs) mais de territoires nerveux !